UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Endocrinologie
Suivi d'obésité
Avec patient
Sans geste clinique

Nom du rédacteur : Manon Faye **Date de rédaction :** 29/01/2024

Relecture intra-ou transdisciplinaire :

Situation de départ N° 51 – Obésité et surpoids

Domaine de compétence n°1 : Aptitude à questionner

Domaine de compétence n°2 : Aptitude à fournir les renseignements au patient

Attendus d'apprentissage de la situation abordée :

1- Recueillir l'histoire pondérale, les circonstances de la prise de poids et caractériser l'obésité par le calcul de l'IMC et la mesure du tour de taille.
2- Caractériser le comportement alimentaire et dépister les troubles des conduites alimentaires.
3- Chercher et prévenir les comorbidités.
4- Évaluer le retentissement psycho-social.
5- Évaluer l'activité physique et la sédentarité.

Patient simulé nécessaire à la station : OUI

Matériel nécessaire à la station : Aucun

Instructions à l'étudiant

Vous êtes interne dans le service d'endocrinologie au CHU. Vous recevez M.POIDS 58 ans qui vous est adressé par son médecin traitant pour initier une prise en charge spécialisée de son obésité (IMC = 36).

Vous avez **8 minutes** pour :

1- Faire l'interrogatoire du patient afin de retracer l'histoire pondérale (pas d'examen physique)

2- Répondre à la question du patient concernant la possibilité de prise en charge par chirurgie bariatrique. Citer les 3 techniques possiblement pratiquées pour ce type de chirurgie et la principale complication commune aux différentes méthodes.

Instructions au patient simulé

Synopsis : *Vous êtes chauffeur de bus, vous avez 58 ans et êtes adressé au CHU par votre médecin traitant pour la prise en charge de votre obésité après échec de traitement nutritionnel et psychothérapeutique bien conduit.*

Un étudiant en médecine va vous interroger (il ne doit pas vous examiner physiquement)

Prénom/ NOM : Olivier POIDS

Âge : 58 ans

Taille et Poids : 1,80 m pour 117 kg (IMC= 36)

Profession : Chauffeur de bus

Situation maritale : Marié

Enfants : 2

Lieu de vie : Appartement en ville

Antécédents : Hypertension artérielle, Diabète de type 2, SAOS (Apnées du sommeil)

Médicaments : Metformine, Analogue du GLP-1, IEC

État esprit : Assis, calme.

<u>Déroulement du scénario</u> : Lorsque l'étudiant vous demande pourquoi vous venez, commencez par :

« *Je viens vous voir de la part de mon médecin traitant pour mon obésité. J'ai vraiment tout essayé docteur et je ne trouve pas de solution j'espère que vous pourrez m'aider. »*

Répondez aux questions de l'étudiant et ne dévoilez les réponses que s'il le demande spécifiquement.
Vous ne répondez aux questions suivantes que si l'étudiant vous les pose. Si la question n'est pas listée, répondez « je ne sais pas ».

Questions potentielles de l'étudiant	Réponses du patient simulé
Avez-vous des antécédents médicaux particuliers à me signaler ?	- *Oui j'ai un diabète et je fais de la tension*
Avez-vous des traitements quotidiens, prenez-vous des médicaments tous les jours ?	- *Je prends le médicament pour la tension : Ramipril, la Metformine et j'ai aussi un autre médicament pour le diabète et pour perdre du poids... je ne me souviens plus du nom mais je dois me faire une piqure 1x par semaine.*
Est-ce que vous fumez ? Combien de cigarettes ?	- *Oui, ½ paquet par jour*
Est-ce que vous buvez de l'alcool ?	- *Occasionnellement*
Consommez-vous de la drogue ?	- *Non*
Avez-vous des allergies ?	- *Pas à ma connaissance*

Est-ce qu'il y a des antécédents médicaux dans votre famille, notamment d'obésité, de maladie cardiaque ou métabolique, ou de cancers ?	- *Mon père et mon frère sont eux aussi en surpoids. Mon père a aussi un stent au cœur.*
Vous vivez seul ?	- *Non je suis marié et j'ai 2 enfants*
Quelle est votre profession ?	- *Je suis chauffeur de bus*
Quels sont votre poids et votre taille actuels ?	- *117 kg pour 1,80m*
Quel a été le poids maximal atteint ?	- *130kg*
Avez-vous identifié à quel moment la prise de poids excessive a débuté ?	- *Je dirais que j'ai toujours été un peu rond depuis l'enfance, mais cela s'est empiré à l'adolescence*
Avez-vous identifié un élément déclencheur à cette prise de poids? Un changement d'environnement? Un choc émotionnel ?	- *Non, pas que je me souvienne*
Vous dites que vous avez « tout essayé pour perdre du poids », c'est-à-dire? Qu'avez-vous essayé ?	- *Eh bien j'ai d'abord essayé beaucoup de régimes qui n'ont jamais marché, j'ai essayé de me remettre au sport mais avec le boulot, les enfants etc je n'arrive pas à trouver le temps. Ensuite mon médecin traitant m'a orienté vers une diététicienne et m'a donné des conseils pour augmenter mon activité physique, cela fait plus de 3 ans, j'ai perdu un peu de poids au début mais maintenant je n'en perds plus.*
En ce qui concerne les repas, combien en faites-vous par jour? De quoi sont-ils composés habituellement ?	- *Je fais 3 repas par jour, et cela dépend, mais le matin c'est 2 tartines de beurre 1 fruit et du café, le midi c'est un sandwich car je n'ai pas le temps avec le travail... et le soir je fais attention, j'essaie de manger plus léger, une soupe en hiver et une salade composée en été avec un yaourt et un fruit.*
Vous grignotez entre les repas ?	- *Très rarement.*
Avez-vous déjà eu des troubles du comportement alimentaire? Vous arrive-t'il d'ingérer de très grandes quantités de nourriture en très peu de temps ?	- *Non*

Pour ce qui est de l'activité physique que faites vous ? Avez-vous des loisirs? Faites vous du sport ?	- *Je ne peux pas en faire la journée au vu de mon métier mais sur conseil de mon médecin traitant je fais du vélo d'appartement 3x par semaine et j'essaie d'aller marcher le weekend avec ma femme.*
Dans la vie de tous les jours est ce que votre obésité impacte votre humeur, vos relations, votre estime de vous ?	- *Oui vous savez dans mon quotidien tout n'est pas adapté pour les personnes en surpoids notamment dans les transports, le cinéma... et puis j'ai beaucoup de mal à me mettre en maillot de bain à la piscine par exemple, alors que j'aime nager et que ça m'aurait plu de reprendre ce sport.*
Est-ce que vous vous sentez stressé ou triste ? Avez-vous un sommeil de qualité ?	- *Non pas stressé ni triste, par contre je dormais mal mais cela va beaucoup mieux depuis que je suis appareillé pour mon apnée du sommeil.*

Question du patient 2 minutes avant la fin ou si l'étudiant vous demande si vous avez des questions : « *Dites moi docteur, j'ai un ami qui a fait une chirurgie pour perdre du poids et ça a vraiment bien marché. Pensez vous que cela serait possible pour moi?* »

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

Fiche de correction pour l'évaluateur (sans le barème)

	Cocher si fait
Tâche 1 : Interrogatoire	
Recherche âge de début de prise de poids excessive + Poids maximal atteint	
Recherche d'antécédents familiaux : - Obésité - pathologies cardiométaboliques - cancers (point accordé si 2/3)	
Recherche des évènements de vie associés à la prise de poids : - Puberté - Changement d'environnement familial - Changement d'environnement professionnel - Choc émotionnel - Sevrage - Arrêt du sport/immobilisation prolongée - Situation sociale précaire (Point accordé si 4/7)	
Evaluation qualitative et quantitative de la consommation alimentaire : - Nombre de repas par jour - Composition des repas - Grignotage - Boissons sucrées - Troubles du comportement alimentaire (point accordé si 3/5)	
Recherche les mesures déjà mises en place pour prendre en charge cette obésité	
Demande si le patient a déjà effectué des régimes restrictifs	
Évalue l'activité physique du patient - Profession - Loisirs - Sport (point accordé si 2/3)	
Évalue le retentissement psychologique de l'excès pondéral : - Stress/anxiété/humeur dépressive - Image de soi - Impact sur la vie quotidienne - Loisirs - Impact sur le sommeil (point accordé si 2/5)	
Tâche 2 : Répond à la question du patient	
Énonce que OUI la chirurgie bariatrique est envisageable dans son cas et justifie :	

IMC >35 + >1 comorbidité susceptible d'être améliorée (cite DT2 et/ou SAOS) et absence de contre-indications	
Explique les différentes possibilités de prise en charge chirurgicale - Anneau - Gastrectomie - By-pass	
Explique la nécessité de passage de dossier en RCP	
Cite la complication commune aux différentes chirurgies = carences vitaminiques	
COMPÉTENCES GÉNÉRIQUES	
Aptitude à questionner	1 à 5
Aptitude à fournir les renseignements au patient	

Fiche de correction avec le barème : non communiqué à l'évaluateur

UNIVERSITÉ CÔTE D'AZUR
FACULTÉ DE MÉDECINE

TUT'ECOS

	Pondération (entre 1 et 5)
Tâche 1 : Interrogatoire	
Recherche âge de début de prise de poids excessive + Poids maximal atteint	3
Recherche d'antécédents familiaux : - Obésité - pathologies cardiométaboliques - cancers (point accordé si 2/3)	4
Recherche des évènements de vie associés à la prise de poids : - Puberté - Changement d'environnement familial - Changement d'environnement professionnel - Choc émotionnel - Sevrage - Arrêt du sport/immobilisation prolongée - Situation sociale précaire (Point accordé si 4/7)	4
Evaluation qualitative et quantitative de la consommation alimentaire : - Nombre de repas par jour - Composition des repas - Grignotage - Boissons sucrées - Troubles du comportement alimentaire (point accordé si 3/5)	4
Recherche les mesures déjà mises en place pour prendre en charge cette obésité	2
Demande si le patient a déjà effectué des régimes restrictifs	3
Évalue l'activité physique du patient - Profession - Loisirs - Sport (point accordé su 2/3)	4
Évalue le retentissement psychologique de l'excès pondéral : - Stress/anxiété/humeur dépressive - Image de soi - Impact sur la vie quotidienne - Loisirs - Impact sur le sommeil	5
Tâche 2 : Répond à la question du patient	
Énonce que OUI la chirurgie bariatrique est envisageable dans son cas et justifie : - IMC >35 + >1 comorbidité susceptible d'être améliorée (cite DT2 et/ou SAOS) et absence de contre-indications	4

TUT'ECOS